

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دانشگاه اصفهان
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی معماری کامپیوتر

پایان نامه کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر گرایش های نرم افزار و هوش مصنوعی

گش: ابزاری برای تشخیص بیماریهای قلبی به کمک هوش مصنوعی

استادان راهنما:
دکتر مهدی کلباسی
دکتر حمید ملا

پژوهشگران:
زینب جنتی
امیرحسین مرادی

شهریور ۱۴۰۵



دانشگاه اصفهان
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه مهندسی فناوری اطلاعات

پروژه کارشناسی رشته‌ی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار و هوش
مصنوعی
خانم زینب جنتی و آقای امیرحسین مرادی
تحت عنوان
گش: ابزاری برای تشخیص بیماریهای قلبی به کمک هوش مصنوعی

در تاریخ ۰۶ / ۱۴۰۵ توسط هیأت داوران زیر بررسی و با نمره به تصویب نهایی رسید.

۱- استاد راهنمای پروژه:
دکتر مهدی کلباسی

امضا

۲- استاد راهنمای پروژه:
دکتر حمید ملا

امضا

۳- استاد داور :
دکتر

امضا

امضای مدیر گروه



دانشگاه اصفهان
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه مهندسی معماری کامپیوتر

پروژه کارشناسی رشته‌ی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار و هوش
مصنوعی
خانم زینب جنتی و آقای امیرحسین مرادی
تحت عنوان
گش: ابزاری برای تشخیص بیماریهای قلبی به کمک هوش مصنوعی

در تاریخ ۰۶ / ۱۴۰۵ توسط هیأت داوران زیر بررسی و با نمره به تصویب نهایی رسید.

۱- استاد راهنمای پروژه:
دکتر مهدی کلباسی

امضا

۲- استاد راهنمای پروژه:
دکتر حمید ملا

امضا

۳- استاد داور :
دکتر

امضا

امضای مدیر گروه

تشکر و قدردانی

دکتر زهرا تیموری جروکانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مسیر پروژه همراه ما بودند. مهربانی و لطفشان فراموش نمی‌شود.

تقدیم به

خانواده عزیزم!

«زینب جنتی»

تقدیم به

آنان که مرا شنیدند!

«امیر حسین مرادی»

چکیده:

قلب در چرخه انقباض خود سیگنال‌های الکتریکی تولید می‌کند. تحلیل درست سیگنال‌های قلبی که نوار قلب نامیده می‌شوند، نقش مهمی در تشخیص بیماری‌ها دارد. در این راستا، دستگاه‌هایی برای دریافت و سنجش نوار قلب ساخته شده و نقطه عطفی در تاریخ پزشکی ایجاد کردند.

تحلیل نوار قلب به دانش و تخصص بالایی نیازمند است. این عامل باعث می‌شود در جوامع محروم که با چالش مراجعه به پزشک متخصص مواجه هستند، مشکلاتی به وجود آید. با توجه به پیشرفت‌های اخیر در هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات، بر آن شدیم سامانه‌ای طراحی کنیم تا با تشخیص خودکار ناهنجاری‌های نوار قلب و ارتباط الکترونیکی پزشک-بیمار، مراجعه بیماران به مراکز تخصصی را کاهش دهد.

گش‌واژه‌های ایرانی به معنای قلب است. هدف از تعریف پروژه گش، توسعه وب اپلیکیشن مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری عمیق برای تشخیص ناهنجاری‌های قلبی نوار قلب بیماران است. کاربران این سامانه، پزشکان و بیماران قلبی هستند. کاربرد این سامانه در تسهیل فرآیند تشخیص است کاربرد و خروجی آن جایگزین تخصص پزشکی نخواهد شد.

مدل یادگیری سامانه گش با استفاده از معماری معرفی شده توسط ژنگ و همکاران توسعه یافته است. این معماری با استفاده از شبکه‌های کانولوشنی و ترنسفورمر^۱ می‌تواند وابستگی‌های محلی و سراسری نوار قلب را به میزان مطلوبی استخراج کند. دادگان^۲ مورد استفاده برای آموزش مدل یادگیری دادگان chapman است.

واژگان کلیدی: قلب، ECG، نوار قلب، تشخیص خودکار ناهنجاری نوار قلب

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۵	فصل اول مقدمه.....
۵	۱-۱- هدف پروژه.....
۵	۲-۱- کاربردهای پروژه.....
۶	۳-۱- ساختار پایان نامه.....
۷	فصل دوم مفاهیم.....
۷	۱-۲- مقدمه.....
۷	۲-۲- ساختار قلب.....
۱۰	۳-۲- جمع بندی.....
۱۱	فصل سوم شرح پروژه.....
۱۱	۱-۳- مقدمه.....
۱۱	۲-۳- وب اپلیکیشن.....
۱۷	۳-۳- مدل یادگیری تشخیص ناهنجاری.....
۲۴	۴-۳- جمع بندی.....
۲۵	فصل چهارم نتایج.....
۲۵	۱-۴- مقدمه.....
۲۵	۲-۴- ارزیابی مدل یادگیری.....
۲۸	۳-۴- جمع بندی.....
۲۹	فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات.....
۳۰	پیوست ۱: لیست برنامه‌ها.....

فهرست شکل‌ها

صفحه	عنوان
۷	شکل ۱-۲: ساختار قلب.....
۸	شکل ۲-۲: شبکه هادی قلب.....
۹	شکل ۳-۲: نوار قلب نرمال.....
۱۰	شکل ۴-۲: شما نوار قلب.....
۱۲	شکل ۱-۳: صفحه خانه.....
۱۲	شکل ۲-۳: صفحه ثبت نام پزشک.....
۱۳	شکل ۳-۳: صفحه ثبت نام بیمار.....
۱۳	شکل ۴-۳: صفحه ورود.....
۱۴	شکل ۵-۳: صفحه ورود.....
۱۴	شکل ۶-۳: صفحه بیمار.....
۱۵	شکل ۷-۳: صفحه بیمار.....
۱۵	شکل ۸-۳: گزارش مدل‌های یادگیری.....
۱۶	شکل ۹-۳: صفحه پزشک.....
۱۶	شکل ۱۰-۳: صفحه پزشک.....
۱۷	شکل ۱۱-۳: صفحه مدیر سامانه.....
۱۸	شکل ۱۲-۳: ساختمان مدل یادگیری.....
۱۹	شکل ۱۳-۳: ساختمان CNN Block.....
۲۰	شکل ۱۴-۳: Transformer Encoder.....

فهرست جدول‌ها

عنوان	صفحه
جدول ۱-۳: پارامترهای هر CNN Block.....	۱۹
جدول ۲-۳: دسته‌های ناهنجاری نوار قلب در پروژه گش.....	۲۱
جدول ۳-۳: دسته Standard.....	۲۱
جدول ۴-۳: دسته Bradyarrhythmia.....	۲۱
جدول ۵-۳: دسته Ischemia and ST-T changes.....	۲۲
جدول ۶-۳: دسته Ventricular arrhythmia.....	۲۲
جدول ۷-۳: دسته Supraventricular arrhythmia.....	۲۲
جدول ۸-۳: دسته Bundle branch abnormalities.....	۲۲
جدول ۹-۳: دسته Abnormal parameters in ECG.....	۲۳
جدول ۱۰-۳: دسته Pre-excitation.....	۲۳
جدول ۱۱-۳: دسته Don't Care.....	۲۳
جدول ۱-۴: ارزیابی کلی مدل ۱ و مدل ۲.....	۲۵
جدول ۲-۴: معیار ارزیابی F1-score به ازای هر برچسب.....	۲۵
جدول ۳-۴: معیار ارزیابی recall به ازای هر برچسب.....	۲۶
جدول ۴-۴: معیار AUROC به ازای هر برچسب.....	۲۶
جدول ۵-۴: معیار acc (accuracy) به ازای هر برچسب.....	۲۶
جدول ۶-۴: معیار TP به ازای هر برچسب.....	۲۷
جدول ۷-۴: معیار FP به ازای هر برچسب.....	۲۷
جدول ۸-۴: معیار TN به ازای هر برچسب.....	۲۷
جدول ۹-۴: معیار FN به ازای هر برچسب.....	۲۸

مخفف‌ها:

Accuracy	ACC
Classify Token	CLS token
Convolutional Neural Network	CNN
Electrocardiography	ECG
False Negative	FN
False Positive	FP
Multi-layer Perceptron	MLP
Multi-Headed Self Attention	MSA or MHSA
Multi-Scaled Embedding Layer	MSEL
One-Time Password	OTP
R-Squared operator	RR
True Negative	TN
True Positive	TP
Token Selection Block	TS-Block

فصل اول

مقدمه

دانش و فناوری آنگاه مطبوع است که در راستای خدمت به جامعه بشری باشد. از ابتدا نیاز انسان به دانستن، دوراندیشی او برای خطر بوده است. این تفکر بر دانایی، آگاهی مان از موضوعات مختلف را توسعه داده و ما را به تمدن امروزی با فناوری‌های پیشرفته آن رسانده است. با اینحال توسعه فناوری همیشه به خیر انسان نینجامیده و بمب‌ها و سلاح‌های ویرانگری را با بی‌مهری تمام به بار آورده است.

در چنین شرایطی تفکر برای آنچه می‌نویسیم و بدان عمل می‌کنیم ضروری می‌شود تا خدای نکرده اسباب زحمت دیگران نشویم و نفرین جاودانه بر جانمان ارزانی نکنیم. ضرورت دانش چیست اگر از آن ترس بر دل‌ها افکنده شود و فریادها به آسمان بلند شود؟ تاریخ گواهی است بر تلاش‌های ستودنی دانشمندی که دانسته‌هایشان مرهمی بر زخم دیگران بوده، شرافتمندانه زیستند و جهان را زیباتر کردند. انسان‌هایی چون لویی پاستور^۲، دکتر محمد قریب^۴ و دکتر توفیق موسیوند^۵، روحشان شاد و قرین رحمت الهی!

در ابتدا قصدمان از تعریف پروژه پایانی دوران کارشناسی، تاسیس شرکتی نوپا^۶ برای توسعه، تولید و فروش دستگاه‌های هولتر ECG^۷ بود. سامانه‌ای که برای توسعه هولتر در نظر داشتیم، سامانه‌ای مبتنی بر اینترنت اشیاء و ارتباط راه دور بیمار با مرکز درمانی بود. این سامانه برخلاف بسیاری از نمونه‌های مرسوم می‌توانست نوار قلب استاندارد ۱۲ لیدی بیمار را دریافت و به سرور سامانه منتقل کند. مدل مبتنی بر هوش مصنوعی سامانه می‌توانست به بررسی ناهنجاری‌های نوار قلب بپردازد و تشخیص ناهنجاری‌ها را تسهیل کند. متأسفانه شرایط نامساعد و دشواری‌های حادثه ما را از هدف آغازین مان بازداشت.

گش پروژه‌ای جامع و عملی نیست. گش سامانه‌ای آزمایشگاهی است که قابلیت توسعه به سامانه‌ای عملی را دارد. در واقع گش تنها بخشی از توسعه وب اپلیکیشن پروژه اول را شامل می‌شود. امید است روزی این توفیق نصیبمان شود با ادامه پروژه اول به این غایت زیبا، خدمت به جامعه بشری، دست یازیم.

۱-۱- هدف پروژه

هدف از تعریف پروژه گش توسعه سامانه‌ای برای تسهیل تشخیص ناهنجاری‌های قلبی است. با توجه به توسعه روزافزون فناوری و عجز شدن آن با زندگی مردم، بر آن شدیم سامانه‌ای طراحی کنیم که با تشخیص خودکار ناهنجاری‌های نوار قلب در بهبود فرآیند درمان اثرگذار باشد.

۱-۲- کاربردهای پروژه

پروژه گش در تسهیل ارتباط پزشک-بیمار و تشخیص خودکار ناهنجاری‌های قلبی کاربرد دارد. با توجه به به کارآمدی معماری‌های نوین یادگیری عمیق و افزایش شمار داده‌های نوار قلب بیماران، می‌توان در مسیر تحول فرآیند درمان سامانه‌هایی پیاده کرد که با یاری پزشکان در تشخیص الگوهای رایج ناهنجاری در نوار

^۲زیست شناس و شیمیدان فرانسوی شناخته شده برای پاستوریزاسیون و واکسیناسیون

^۴بنیانگذار پزشکی کودکان در ایران

^۵مخترع نخستین قلب مصنوعی جهان

^۶Startup

^۷هولتر ECG دستگاهی است که نوار قلب بیمار را زمانی که در بیمارستان حضور ندارد ثبت می‌کند.

قلب، دقت مداوای بیماران را ارتقاء بخشد.

۱-۳- ساختار پایان نامه

در فصل دوم به توضیح مختصر قلب می‌پردازیم. در این فصل با ساختار قلب، دستگاه گردش خون و نوار قلب آشنا می‌شویم. در فصل سوم به بیان جزییات پیاده‌سازی پروژه می‌پردازیم. در این فصل با ساختار وب اپلیکیشن و معماری مدل یادگیری آشنا می‌شویم. در فصل چهارم به بیان نتایج ارزیابی مدل یادگیری می‌پردازیم. در فصل ششم مسیرهای توسعه و رشد پروژه را به تخلص بیان می‌کنیم.

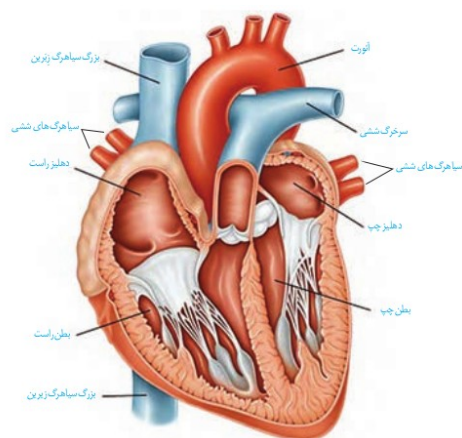
فصل دوم مفاهیم

۲-۱- مقدمه

با توجه به اینکه پروژه گش در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان نگارش یافته است و مخاطبان آن مهندسان و دانشجویان رشته‌های مهندسی هستند، قصد داریم در این فصل به بررسی قلب و دستگاه گردش خون بپردازیم. این فصل بسیار عمومی نوشته شده است تا بینشی کلی نسبت به نوار قلب و نقش آن در تشخیص سلامتی بیماران حاصل شود. با این حال اگر احساس کردید مطالب این فصل برایتان کفایت نمی‌کند، از شما دعوت می‌کنیم به درسنامه قلب و عروق دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی مراجعه کنید^۱

۲-۲- ساختار قلب^۲

قلب اندامی ماهیچه ای است که در طول عمر فردی با عمر متوسط تقریباً سه میلیارد بار منقبض می‌شود. وظیفه قلب پمپاژ خون به تمام نقاط بدن است. با اینکار مواد مغذی و اکسیژن به سلول‌ها می‌رسد و مواد زائد و کربن دی‌اکسید تولید شده آن‌ها از بدن خارج می‌شود. قلب از چهار حفره به نام‌های دهلیز راست، دهلیز چپ، بطن راست و بطن چپ تشکیل شده است. ساختار قلب را در شکل ۱-۲ مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۲: ساختار قلب

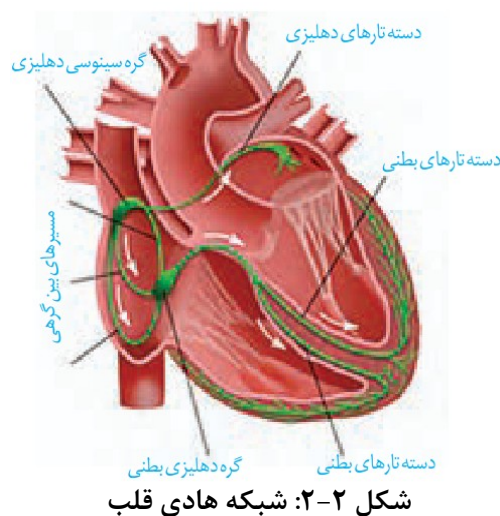
دهلیزها حفره‌های ورودی قلب و بطن‌ها حفره‌های خروجی آن هستند. خون اندام‌های بدن از بزرگ سیاهرگ‌های زیرین و زبرین به دهلیز راست وارد می‌شود. بعد از انباشته شدن خون در دهلیز راست،

ماهیچه‌های دیواره آن منقبض شده و محتویات خود را به بطن راست می‌ریزند. سپس بطن راست منقبض می‌شود و خون درون خود را برای مبادلات گازی به شش‌ها می‌فرستد. در شش‌ها خون کربن‌دی‌اکسید از دست می‌دهد و سرشار از اکسیژن می‌شود. خون غنی از اکسیژن به دهلیز چپ وارد می‌شود و بعد از انقباض دهلیز چپ، با انقباض بطن چپ به تمام سلول‌های بدن فرستاده می‌شود.

۲-۲-۱ چرخه ضربان قلب

انقباض قلبی بر اساس فعالیت بدن تنظیم می‌شود. آهنگ انقباض قلبی چرخه ضربان قلب نام دارد. در هر دور چرخه ضربان قلب، انقباض و انبساط بخشی از قلب انجام می‌شود تا در همکاری ماهیچه‌های مختلف آن، نیاز اندام‌ها به خون و مواد مغذی برآورده شود. در زمان استراحت^۸ هر چرخه ضربان قلب ۰.۸ ثانیه به طول می‌انجامد که شامل استراحت عمومی، انقباض دهلیزها و انقباض بطن‌ها می‌شود. در استراحت عمومی هیچ ماهیچه‌ای منقبض نمی‌شود. در این مرحله خون بزرگ‌سیاهرگ‌ها به دهلیز راست و خون سیاهرگ‌های ششی به دهلیز چپ وارد می‌شود (۰.۴ ثانیه). بعد از استراحت عمومی، انقباض دهلیزها رخ می‌دهد و بطن‌ها از خون پر می‌شوند (۰.۱ ثانیه). در نهایت بطن‌ها منقبض شده و خون به شش‌ها و سراسر بدن ارسال می‌شود (۰.۳ ثانیه).

با اینکه دستگاه عصبی، هرمون‌ها و سایر بخش‌های بدن توانایی اثرگذاری بر فعالیت قلب را دارند، تحریک اصلی قلب توسط شبکه هادی قلب انجام می‌شود. شبکه هادی قلب از سلول‌های ماهیچه‌ای اختصاص یافته تشکیل شده است که در دو گره سینوسی-دهلیزی، دهلیزی-بطنی و دسته‌ای از رشته‌های ماهیچه‌ای سامان می‌یابد. این شبکه در سراسر قلب پخش شده و انقباض قلبی را تنظیم می‌کند. شکل ۲-۲ شبکه هادی قلب را نشان می‌دهد.

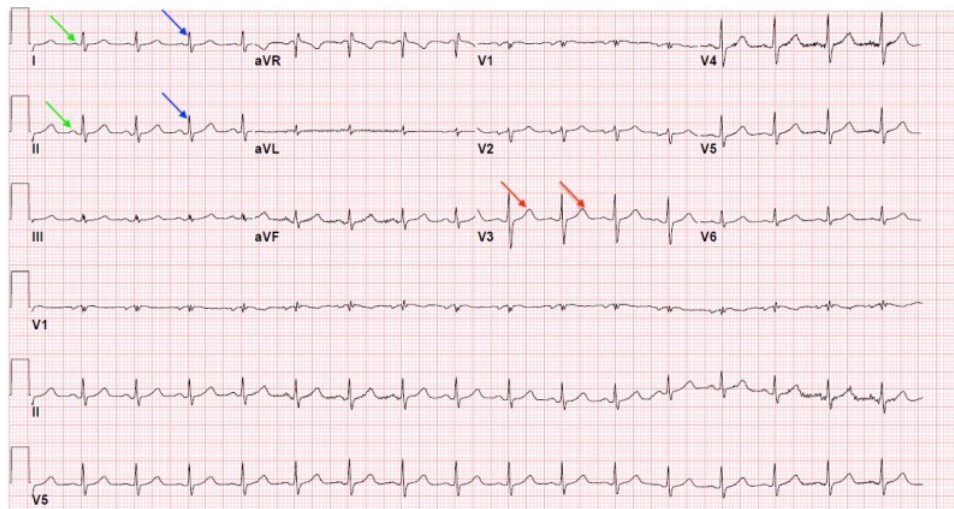


۲-۲-۲ نوار قلب (ECG)

در چرخه ضربان قلب سیگنال‌های الکتریکی تولید می‌شود. از آنجا که شمار زیادی سلول در این فعالیت مشارکت می‌کنند، می‌توان سیگنال‌های الکتریکی قلبی را در سطح پوست دریافت کرد. نمودار رسم شده از سیگنال‌های قلبی نوار قلب نام دارد. ثبت و گزارش نوار قلب نمای جامعی از فعالیت الکتریکی قلب ارائه می‌کند. برای دریافت نوار قلب، الکترودهایی بر پوست نقاط مختلف بدن متصل می‌شود. سیگنال‌های دریافتی

^۸ زمانی که فعالیت خاصی انجام نمی‌دهیم.

ابتدا تصفیه^۹ شده، سپس از اعمال عملیات‌های ریاضی روی آنها، کمیت‌هایی به نام لید^{۱۰} به دست می‌آید. بر اساس شرایط و کاربرد، آزمون نوار قلب می‌تواند شمار مختلفی لید را شامل شود. با اینحال، نوار قلب استاندارد بیمارستانی^{۱۲} لید دارد که از اتصال ۱۰ الکتروود روی دست‌ها، پاها و سینه بیمار به دست می‌آید^{۱۱}. شکل ۲-۳ نمونه‌ای از نوار قلب نرمال ۱۲ لیدی را نشان می‌دهد.^{۱۲}



شکل ۲-۳: نوار قلب نرمال

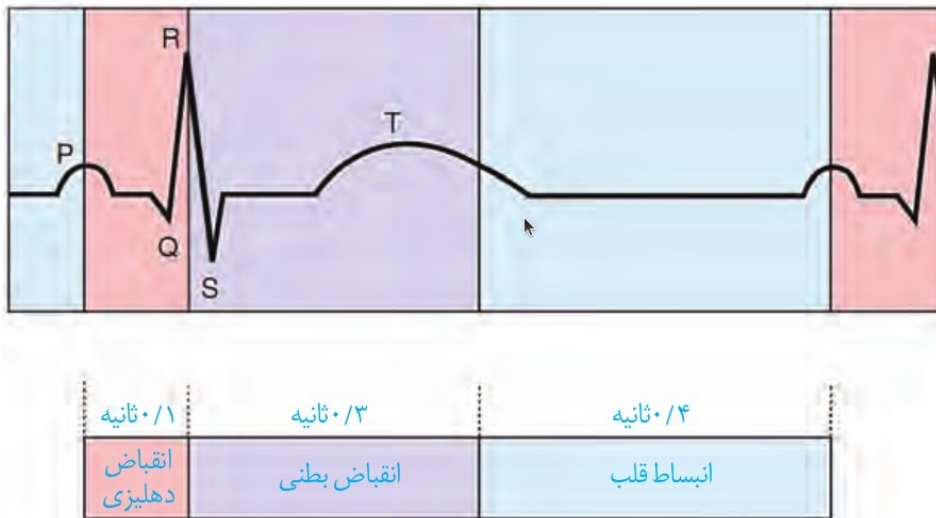
۳-۲-۲ تحلیل نوار قلب (ECG)

نوار قلب از تعدادی موج تشکیل شده است که به صورت متناوب تکرار می‌شوند. این موجها که هر کدام نشانگر تحریک خاصی هستند، موج‌های P، QRS، T، U نامیده می‌شوند. موج P نشانگر تحریک دهلیزی است. این موج از گره سینوسی-دهلیزی انتشار یافته و آغازگر چرخه ضربان قلب است. موج QRS از گره دهلیزی-بطنی انتشار می‌یابد و بطن‌ها را تحریک به انقباض می‌کند. به دلیل اینکه بطن‌ها خون را به خارج از قلب می‌فرستند، ارتفاع موج QRS از موج P بیشتر است. موج T برای استراحت عمومی انتشار می‌یابد و بطن‌ها را منبسط می‌کند. دقت داشته باشید موج‌های قلبی محرک موارد گفته شده هستند و از زمان انتشار موج تا زمان رخداد موارد گفته شده قدری تأخیر زمانی وجود دارد. شکل ۲-۴ شمایی از نوار قلب را نشان می‌دهد.

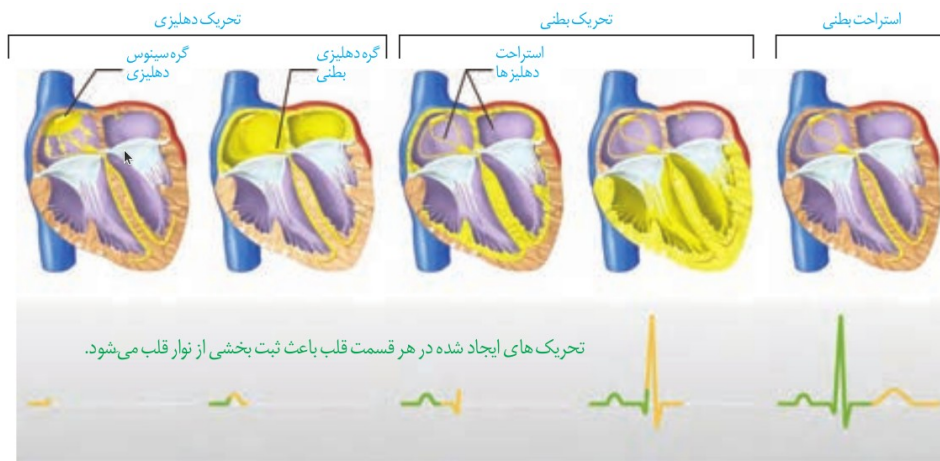
^۹ Denoising
^{۱۰} Lead

^{۱۱} نام لیدها: I, II, III, aVF, aVL, aVR, V1, V2, V3, V4, V5, V6

^{۱۲} برای اطلاعات بیشتر درباره نوار قلب ۱۲ لیدی به سایت زیر مراجعه کنید: <https://ecg.utah.edu/lesson/1>



شکل ۲-۴ الف: شِما نوار قلب



شکل ۲-۴ ب: تحریک‌های متناسب با هر موج نوار قلب

پزشکان با بررسی نوار قلب به تشخیص ناهنجاری‌های قلبی می‌پردازند. برای مثال، نوار قلب روی کاغذ میلیمتری چاپ می‌شود. پزشک با شمارش مربع‌های بین دو موج یکسان شمار ضربان قلب در دقیقه را به دست می‌آورد. در بسیاری از بیماری‌های قلبی، شکل موج‌های نوار قلب تغییر می‌کند. برای مثال بزرگ شدن قلب می‌تواند باعث افزایش ارتفاع موج QRS شود، سکتة قلبی باعث کاهش ارتفاع موج QRS شود و اشکال در شبکه هادی قلب می‌تواند باعث افزایش فاصله موج‌های قلبی شود.

۳-۲- جمع‌بندی

در این فصل با ساختار قلب و چرخه ضربان قلب آشنا شدیم. دانستیم فعالیت‌های قلبی با سیگنال‌های الکتریکی تنظیم می‌شود. با نوار قلب به عنوان آزمون برای سنجش عملکرد الکتریکی قلب آشنا شدیم و به نقش آن در تشخیص بیماری‌ها پرداختیم.

فصل سوم شرح پروژه

۳-۱- مقدمه

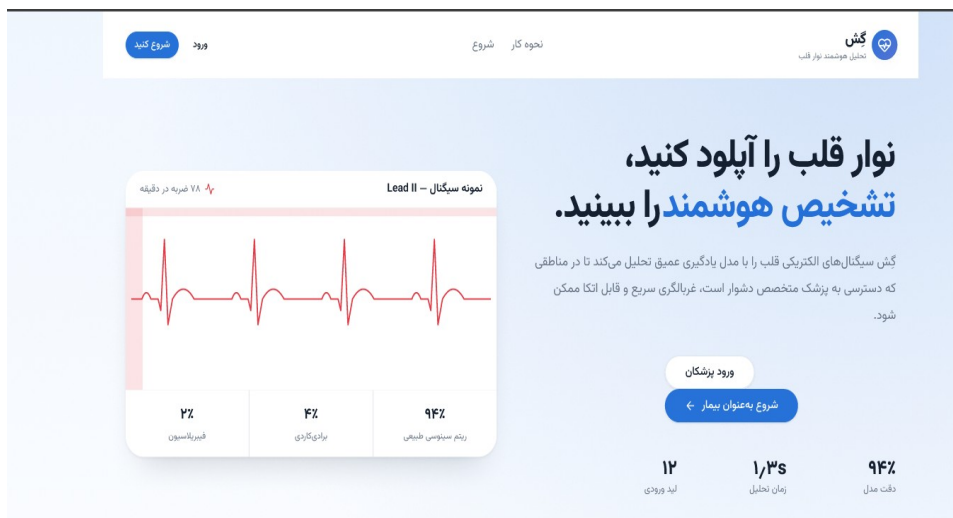
هدف از تعریف پروژه گش پیاده‌سازی سامانه‌ای برای تسهیل فرایند درمان است. این سامانه می‌تواند به ارتقاء رضایت مراجعین و دسترسی پزشکان کمک کند. پروژه گش دو بخش اصلی را شامل می‌شود. در بخش اول پیاده‌سازی وب اپلیکیشن انجام شده است. در این بخش رابط کاربری مراجعین پیاده شده تا مراجعین توانایی تعامل با سامانه را به دست آورند. در بخش دوم مدل یادگیری تشخیص ناهنجاری‌های نوار قلب پیاده شده است. این مدل، دسته‌بندی نوار قلب ورودی را بر اساس ناهنجاری احتمالی یا سلامت انجام می‌دهد. در ادامه به تفصیل هر بخش می‌پردازیم.

۳-۲- وب اپلیکیشن

کاربری سامانه بر بستر وب و در قالب وب‌اپلیکیشن تعریف شده است. در این راستا کاربران می‌توانند در سامانه ثبت نام کرده و از خدمات تشخیصی و ارتباطی آن استفاده کنند. سهولت کاربری، عاملی مهم در طراحی سامانه بوده است.

۳-۲-۱ مازول‌ها و ویژگی‌ها

کاربران با ثبت نام در سامانه توانایی استفاده از خدمات آن را به دست می‌آورند. در این راستا، امکان ثبت و اصالت سنجی با شماره ملی، شماره تلفن همراه و پست الکترونیکی فراهم شده است. در سامانه گش سه نقش بیمار، پزشک و مدیر سامانه تعریف شده است. بیمار قابلیت بارگذاری آزمایشات، دریافت نتایج سامانه و مشاوره مجازی با پزشکان حقیقی را دارا می‌باشد. پزشک با احراز اصالت پزشکی، توانایی پذیرش بیماران، دریافت نتایج مدل یادگیری و مشاوره بیماران را دارا می‌باشد. مدیر سامانه توانایی اداره سامانه، رسیدگی به وضعیت کاربران (تعیین اصالت، حذف حساب کاربری و ...) و حل مشکلات جاری را دارا می‌باشد. شکل‌های ۳-۱ تا ۳-۱۱ کاربری سامانه را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۱: صفحه خانه. در این صفحه اطلاعات کلی و راه‌های استفاده از سامانه آورده شده است.

شکل ۳-۲: صفحه ثبت نام پزشک. در فازهای بعدی پروژه، با استفاده از شماره نظام پزشکی، وبسایت نظام پزشکی و نرم افزار خزگر وب، اصالت سنجی پزشکی انجام خواهد شد.

ثبت نام

ورود

بیمار

پزشک

نام و نام خانوادگی *
مثلا زینب چنثی

شماره موبایل *
0913456997

ایمیل *
example@email.com

رمز عبور *

ساخت حساب

گش

تحلیل هوشمند بیمار قلب

غریبالگری قلب در چند ثانیه!

حساب کاربری خود را بسازید تا نوار قلب را آپلود کنید و نتیجهی تحلیل مدل را همراه با نظر پزشک دریافت کنید.



شکل ۳-۳: صفحه ثبت نام بیمار

ثبت نام

ورود

شماره موبایل یا کد ملی
0913456997

رمز عبور

ورود به سامانه

ورود با کد ایمیل

گش

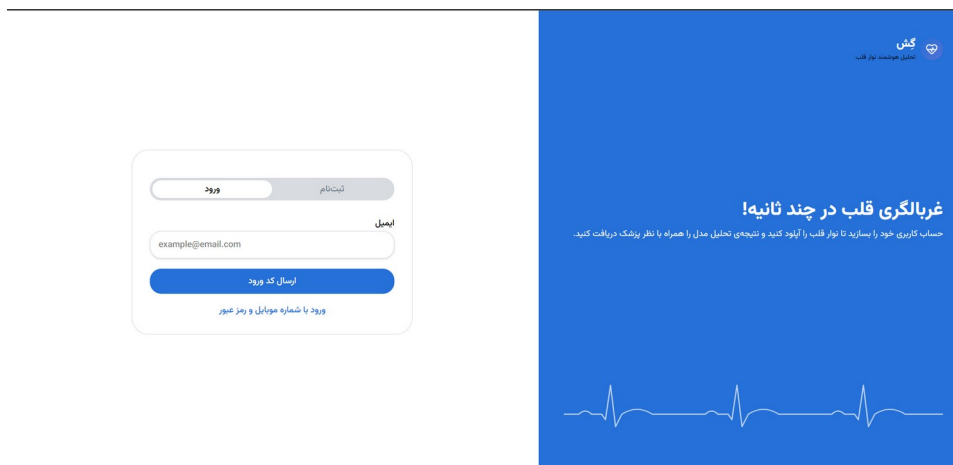
تحلیل هوشمند بیمار قلب

غریبالگری قلب در چند ثانیه!

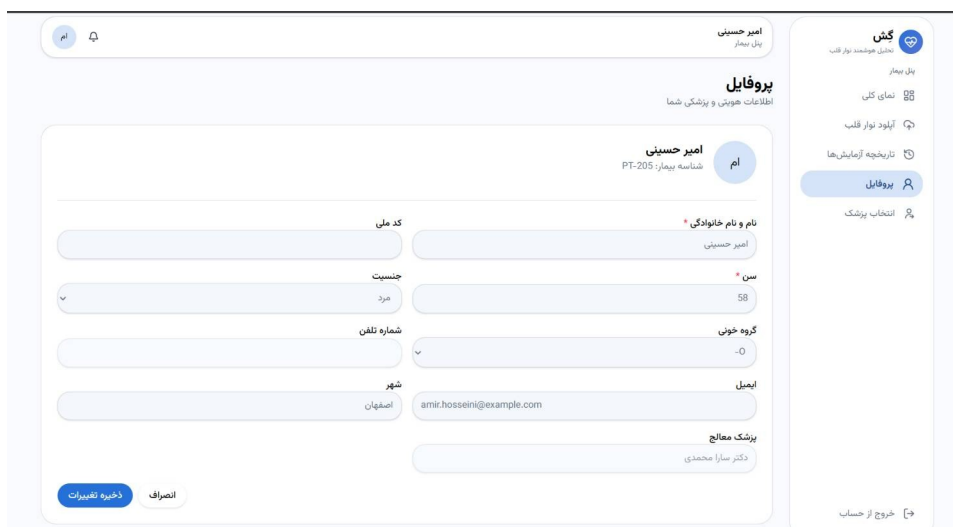
حساب کاربری خود را بسازید تا نوار قلب را آپلود کنید و نتیجهی تحلیل مدل را همراه با نظر پزشک دریافت کنید.



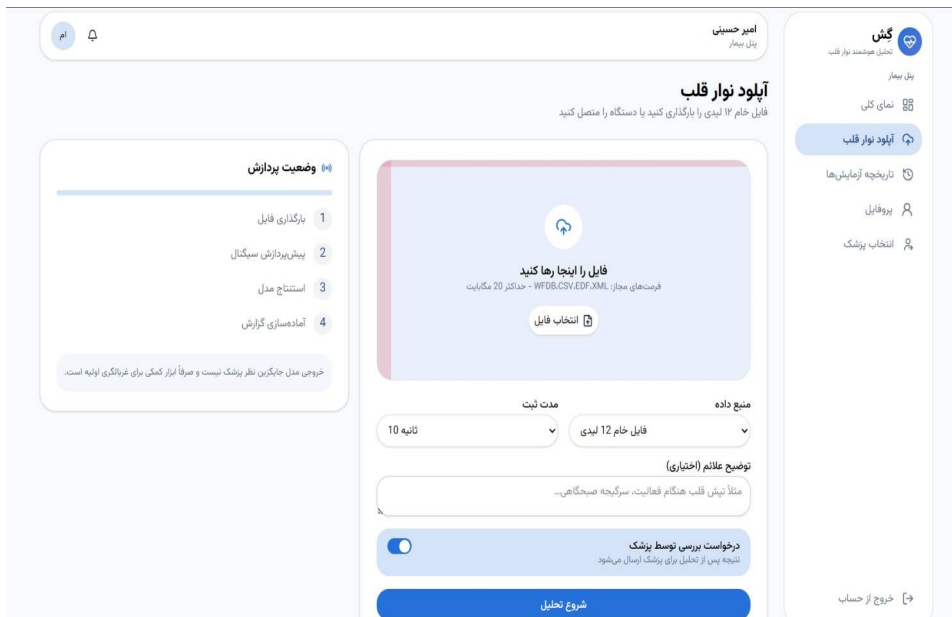
شکل ۳-۴: صفحه ورود با رمز ایستا



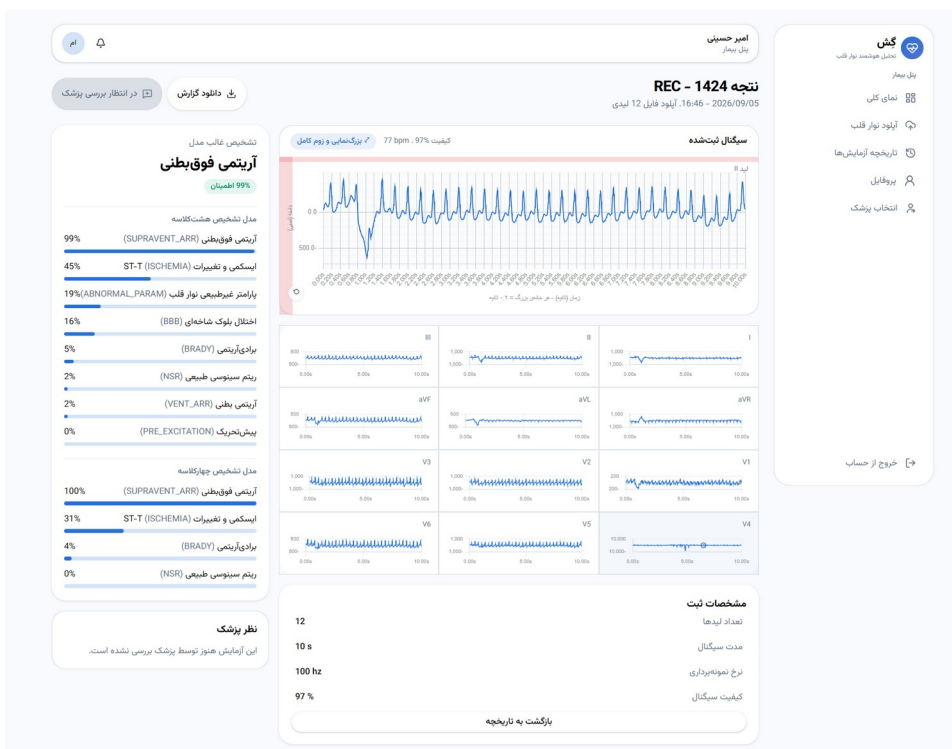
شکل ۳-۵: صفحه ورود با رمز یکبار مصرف ایمیل



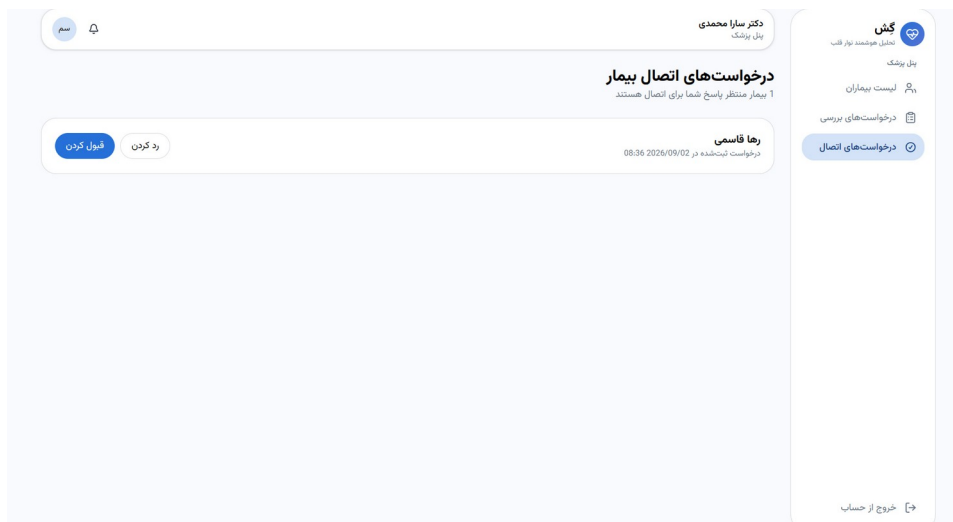
شکل ۳-۶: صفحه بیمار. در این بخش اطلاعات جامع بیمار قابل مشاهده است.



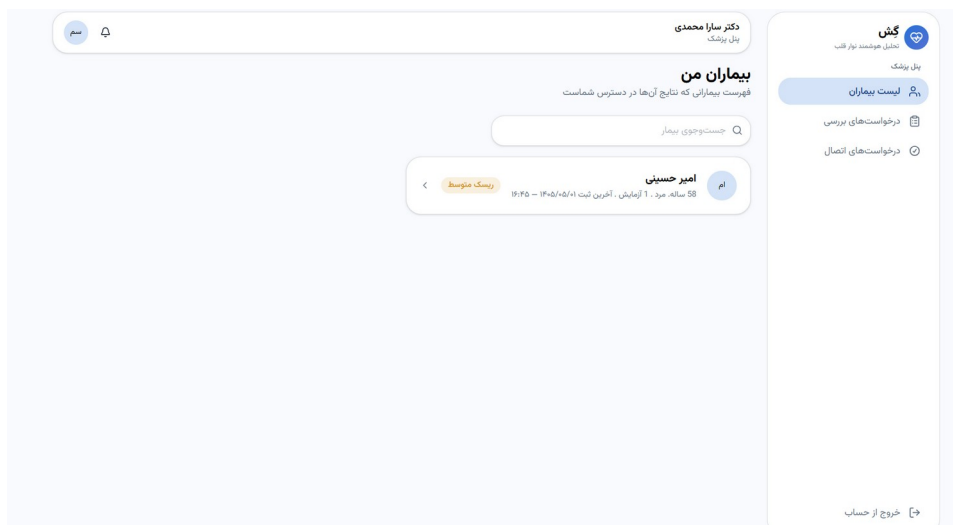
شکل ۳-۷: صفحه بیمار. در این صفحه نوار قلب برای تشخیص مدل یادگیری بارگذاری می‌شود.



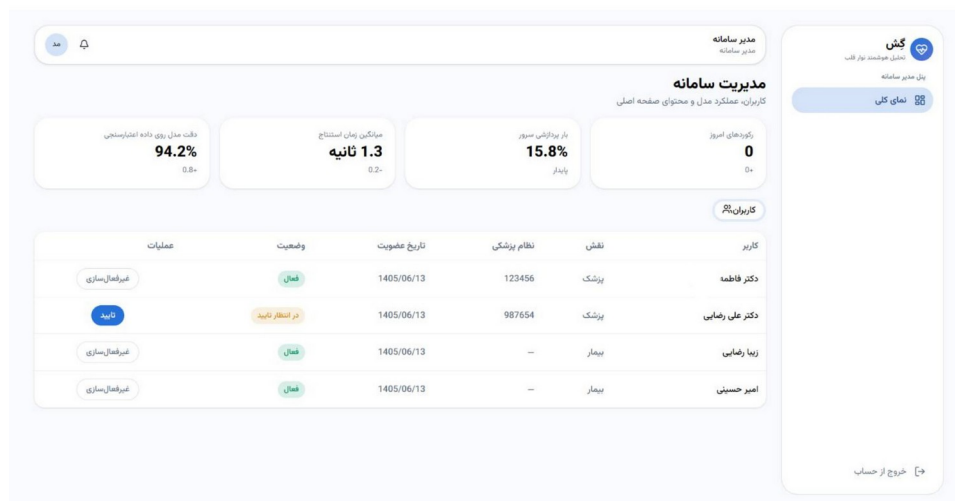
شکل ۳-۸: گزارش مدل‌های یادگیری. در این صفحه نوار قلب بیمار به همراه نتایج مدل‌های یادگیری نمایش می‌یابد. درصد تعلق به هر گروه خروجی تابع سیگموئید (sigmoid) آن گروه است.



شکل ۳-۹: صفحه پزشک. پزشک قابلیت تایید درخواست بیماران را دارد



شکل ۳-۱۰: صفحه پزشک. در این صفحه پزشک بیماران خود را یکجا مشاهده می‌کند.



شکل ۳-۱۱: صفحه مدیر سامانه. مدیر سامانه توانایی پایش اعضا را دارد در این راستا، مدیر می تواند عضویت اعضا جدید را تایید یا عضویت سایر اعضا را لغو کند.

۳-۲-۲ بک اند و فرانت اند

ساختار پایدار و شیء‌گرا زبان برنامه نویسی جاوا آن را به گزینه مناسبی در توسعه سامانه‌های چند بخشی تبدیل کرده است. بک اند سامانه با استفاده از چارچوب^{۱۳} Spring Boot (Java) و پایگاه داده با استفاده از PostgreSQL توسعه یافته است. فرانت اند سامانه با استفاده از React، React Router، Context و Tailwindcss توسعه یافته است.

برای ثبت نام در سامانه استفاده از رمز یکبار مصرف جیمیل^{۱۴} و رمزگذاری BCrypt تعبیه شده است. در پیاده سازی فرانت اند از اعتبارسنجی شماره ملی در تعامل با بک اند و همچنین مدیریت state مرکزی با Context استفاده شده است.

۳-۳-۳ مدل یادگیری تشخیص ناهنجاری

برای تشخیص خودکار ناهنجاری‌های قلبی به پیاده سازی مدل یادگیری احتیاج داریم. با پیاده سازی معماری مناسب، مدلی تعریف کردیم که با آموزش روی دادگان با شمار بالای نوار قلب، توانایی دسته بندی ناهنجاری قلبی را با دقت مناسبی به ارمغان آورد. معماری مینا برای توسعه این پروژه از مقاله ژنگ و همکاران گرفته شده است.^۵ در پروژه گش دو مدل یادگیری برای انجام دسته بندی چند برچسبی^{۱۵} توسعه یافته اند.

۳-۳-۱ مقدمه ای بر معماری های استفاده شده

معرفی ترنسفورمر در سال ۲۰۱۷^۶ انقلاب بزرگی در توسعه مدل های زبانی^{۱۶} پدید آورد. مکانیسم attention به کار رفته در ترنسفورمر، برخلاف معماری های رایج آن روز، مدل های حاوی ترنسفورمر را قادر به

^{۱۳}framework

^{۱۴}سیستم OTP گوگل: Gmail SMTP

^{۱۵}Multi-label classification

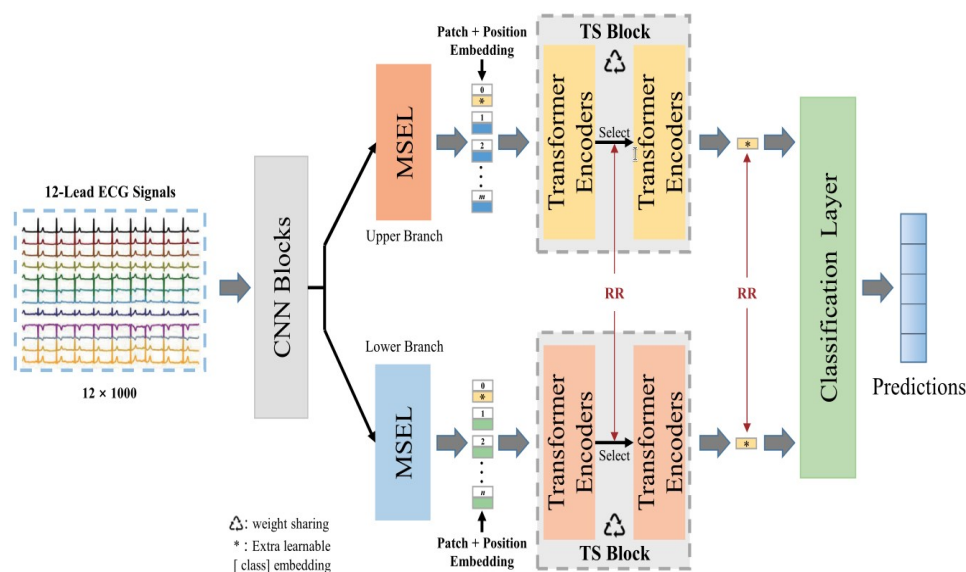
^{۱۶}Language Model(LM)

استخراج وابستگی‌های کلی متن و تولید نتایج بهتر می‌کند. توسعه مدل‌های زبانی بزرگ^{۱۷} در چند سال گذشته مدیون بکارگیری و توسعه این معماری بوده است. نخستین ترنسفورمر از کنار هم قرار گرفتن دو ساختمان به نام‌های transformer encoder و transformer decoder تشکیل شده است. بعد از معرفی ترنسفورمر، معماری‌های دیگری بر پایه آن توسعه یافته و معرفی شدند.

نتایج امیدبخش ترنسفورمر در آموزش مدل‌های متنی، پژوهشگران را به فکر بهره‌مندی از آن در حوزه‌های دیگری چون پردازش سیگنال و تصویر انداخت. تا آن زمان معماری مورد توجه برای پردازش سیگنال، شبکه‌های عصبی کانولوشنی^{۱۸} بود. اما شبکه‌های کانولوشنی با توانایی بالایی که در استخراج وابستگی‌های محلی دارند، از استخراج وابستگی‌های کلی، مخصوصاً در اندازه بزرگ داده، ناتوان هستند. چالش اصلی بکارگیری ترنسفورمر در پردازش سیگنال و تصویر تفاوت ماهوی این حوزه‌ها است. در حوزه متن، توکن‌ها^{۱۹} اجزای تشکیل‌دهنده متن هستند اما در سیگنال ولتاژ و در تصویر پیکسل‌ها اجزای تشکیل‌دهنده هستند. اعمال یکباره ترنسفورمر روی سیگنال و تصویر با شمار بسیار زیاد داده سبب می‌شود آموزش مدل کند شود، ارتباطات به درستی استخراج نشده و نتایج مطلوب حاصل نشود. دوسوویسکی و همکاران راه حلی برای این چالش ارائه کردند.^۷ آن‌ها پیشنهاد کردند تصویر ابتدا قطعه قطعه شده و هر قطعه مانند توکن متنی به ترنسفورمر وارد شود. به این ترتیب ترنسفورمر به پردازش تصویر وارد شد و نتایج درخشانی به بار آورد.

۳-۲-۳ معماری مدل یادگیری^{۲۰}

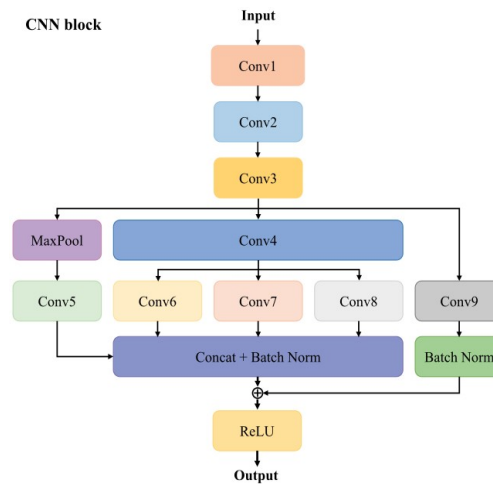
بر اساس معماری معرفی شده در مقاله مرجع، این مدل از یک ساختار دو شاخه استفاده می‌کند. در این مدل از قابلیت استخراج وابستگی محلی شبکه کانولوشنی و استخراج وابستگی کلی ترنسفورمر استفاده شده است. در شکل ۳-۱ معماری مدل یادگیری را مشاهده می‌کنید.



شکل ۳-۱۲: ساختمان مدل یادگیری

ورودی مدل نوار قلب ۱۲ لیدی است. در ساختمان مدل، ابتدا از شبکه‌های کانولوشنی استفاده می‌شود. در CNN Blocks از دو CNN Block متوالی استفاده شده است. ساختمان هر CNN Block در شکل ۳-۱۳ آورده شده است. مشخصات اجزای شکل ۳-۲ در جدول ۳-۱ آمده است.

Large Language Model (LLM)^{۱۷}
Convolutional Neural Network (CNN)^{۱۸}
توکن‌ها با پیش پردازش روی واژگان به دست می‌آیند.
مدل یادگیری تشخیص ناهنجاری‌های نوار قلب بیماران^{۲۰}



شکل ۳-۱۳: ساختمان CNN Block

جدول ۳-۱: پارامترهای هر CNN Block.

در این جدول پارامترهای شبکه‌های کانولوشنی به کار رفته در CNN Block آمده است.

لایه کانولوشن	Filter	Stride	Padding	out_channels
Conv1	۷	۱	۳	۱۲۸
Conv2	۵	۱	۲	۲۵۶
Conv3	۳	۱	۱	۱۲۸
Conv4	۱	۱	۰	۳۲
Conv5	۱	۱	۰	۳۲
Conv6	۳۹	۱	۱۹	۳۲
Conv7	۱۹	۱	۹	۳۲
Conv8	۹	۱	۴	۳۲
Conv9	۱	۱	۰	۱۲۸

بعد از استخراج ویژگی‌های محلی توسط شبکه‌های کانولوشنی، خروجی بلوک دوم CNN Blocks به طور یکسان به دو بلوک MSEL در شاخه بالایی و شاخه پایینی وارد می‌شود. بلوک‌های MSEL^{۲۱} به تعبیه سازی^{۲۲} سیگنال با مقیاس‌های متفاوت می‌پردازند. در بلوک MSEL دو کرنل کانولوشن با ابعاد مختلف وجود دارد. در شاخه پایینی از دو کرنل با اندازه‌های بسیار متفاوت 1x5 و 1x100 و در شاخه بالایی از دو کرنل با اندازه‌های کمتر متفاوت 1x20 و 1x40 استفاده شده است. در هر شاخه، دو کرنل طوری روی هم قرار می‌گیرند که مرکزشان مشترک باشد و گام^{۲۳} هر شاخه برابر با اندازه کرنل بزرگ‌تر باشد. با پیمایش کرنل‌ها به شیوه‌ای که بیان شد دو دسته توکن به تعداد برابر و مرکز مشترک به دست می‌آید. توکن‌های هم‌مرکز به هم متصل شده و توکن‌های جدیدی به وجود می‌آورند. به این ترتیب، سیگنال اولیه با شمار بسیار زیاد نمونه^{۲۴} به تعداد محدودتری توکن تبدیل می‌شود که قابلیت پردازش توسط transformer encoder را دارد.

خروجی MSEL شامل توکن‌های هم‌مرکز گفته شده، CLS token و یک افزونه position embedding

Multi-Scale Embedding Layer^{۲۱}

Embedding^{۲۲}

Stride^{۲۳}

sample^{۲۴}

آموزش پذیر است. این افزونه در پردازش اهمیت مکانی توکن‌ها اهمیت دارد. خروجی MSEL به صورت زیر است:

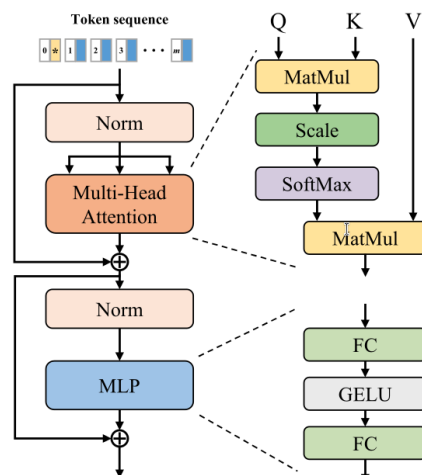
$$X = [x^c; x^1; \dots; x^m] + E_{pos}$$

که در آن X^c همان CLS token و E_{pos} نیز position embedding آموزش پذیر است. اگر m تعداد توکن‌ها و D اندازه توکن‌ها باشد (به اندازه بزرگترین کرنل در ساختمان MSEL)، داریم:

$$x^c, x^1, x^2, \dots, x^m \in \mathbb{R}^D$$

$$E_{pos} \in \mathbb{R}^{m \times D}$$

خروجی MSEL به TS-Block وارد می‌شود. در شاخه بالایی و پایینی از معماری یکسانی برای پیاده‌سازی TS-Block استفاده شده است. در این ساختمان از دو Transformer Encoder با قابلیت اشتراک اوزان در ابتدا و انتها به همراه یک ساختار گزینش توکن استفاده شده است. همانطور که گفته شد، خروجی MSEL شامل توکن‌های هم‌مرکز متصل‌شده، CLS token و افزونه اطلاعاتی مکان توکن‌ها می‌شود. اولین توکن CLS token است. در جریان پردازش transformer encoder، این توکن اطلاعات استخراج شده از سایر توکن‌ها را شامل می‌شود. در شکل ۳-۱۴ معماری transformer encoder را مشاهده می‌کنید.



شکل ۳-۱۴: Transformer Encoder
دایره‌ای که در آن + قرار گرفته به معنای element-wise addition است.

در MSA، ماتریس‌های Query، key و Value از روی رشته ورودی X ساخته شده ($K, Q, V \in \mathbb{R}^{(m+1) \times D}$) و سپس مکانیسم Attention روی آن‌ها اعمال می‌شود:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{Softmax}(QK^T / \sqrt{D})V$$

با توجه به این که معمولاً نشانه‌های ناهنجاری‌های قلبی در بخش کوچکی از نوار قلب نمود پیدا می‌یابد، باید مکانیسمی وجود داشته باشد تا مهمترین توکن‌های مرحله اول پردازش Transformer encoder را جدا کرده و برای پردازش مجدد به transformer encoder منتقل کند. فرآیند انتخاب مناسبترین token های حاصل از پردازش transformer encoder را token selection می‌نامیم. در ادامه به شرح این فرآیند می‌پردازیم.

پیشتر به ماتریس X ورودی به transformer encoder پرداختیم و دانستیم شامل $m+1$ توکن هرکدام به اندازه D است که توکن اول آن CLS token است. ابعاد خروجی transformer encoder مشابه ابعاد اولیه آن

است؛ یعنی خروجی آن شامل $m+1$ توکن هر کدام به اندازه D است. در فرآیند token selection ابتدا CLS token جدا می‌شود. باقی توکن‌ها به ترتیب نزولی اهمیت‌شان (اهمیت هر توکن از CLS token استخراج می‌شود) مرتب شده و کسری از آنها برای پردازش مجدد در transformer encoder انتخاب می‌شوند. CLS token حاصل از دومین پردازش transformer encoder به عنوان خروجی TS-Block تعیین می‌شود.

ورودی‌های مختلف به شاخه‌های بالایی و پایینی TS-Block سبب می‌شود، علاوه بر معماری یکسان، استخراج ویژگی در دو مقیاس مختلف انجام شود. خروجی هر دو شاخه در نهایت به Classification Layer وارد می‌شود. در این لایه تشخیص ناهنجاری انجام شده و خروجی نهایی تولید می‌شود.

۳-۳-۳ دادگان

همانطور که گفته شد، نوار قلب استاندارد از ۱۲ لید تشکیل شده است. درواقع هر لید، تصویری متمایز از فعالیت الکتریکی قلب نمایش می‌دهد.

در سال‌های اخیر توسعه معماری‌های گوناگون یادگیری عمیق سبب امیدواری به آینده این شاخه از هوش مصنوعی شده است. با اینحال وجود دادگان با شمار کافی داده برای آموزش آنها از چالش‌های پیشرو در توسعه مدل‌های یادگیری عمیق است. این چالش در طراحی مدل‌های دسته‌بندی ناهنجاری قلبی هم وجود دارد و متأسفانه دادگان معدودی در این زمینه منتشر و در اختیار عموم قرار گرفته است.

برای آموزش مدل یادگیری از دادگان Chapman-Shaoxing 12-lead ECG database استفاده شده است.^۸ این دادگان ابتدا شامل ۱۰۰۰۰ نمونه بود که اکنون به ۴۵۱۰۰ نمونه افزایش یافته است. هر نمونه مشتمل بر ۱۰ ثانیه نوار قلب ۱۲ لیدی با نرخ نمونه برداری ۲۵۰۰ ۵۰۰ نمونه بر ثانیه و فراداده‌ای از نوع سن و جنسیت است. نمونه‌های این دادگان شامل ۶۲ برچسب ناهنجاری هستند.

برای آموزش مدل نرخ نمونه برداری را به ۱۰۰ نمونه بر ثانیه کاهش دادیم و از ۸ دسته در مدل اول و ۴ دسته در مدل دوم استفاده کردیم (جدول ۳-۲). گروه‌بندی دسته‌ها در جدول‌های ۳-۳ تا ۳-۱۱ آمده است.^۹

جدول ۳-۲: دسته‌های ناهنجاری نوار قلب در پروژه گش

superclasses	Model 1	Model 2
Standard	✓	✓
Bradyarrhythmia	✓	✓
Ischemia and ST-T changes	✓	✓
Ventricular arrhythmia	✓	
Supraventricular arrhythmia	✓	✓
Bundle branch abnormalities	✓	
Abnormal parameters in ECG	✓	
Pre-excitation	✓	

جدول ۳-۳: دسته Standard

Sinus Rhythm

جدول ۳-۴: دسته Bradyarrhythmia

degree atrioventricular block ۱
degree atrioventricular block ۲

Sample rate^{۲۵}

^{۲۶}دسته بندی برچسب‌ها توسط دکتر زهرا تمیوری جروکانی انجام شده است.

degree atrioventricular block(Type one) ٢
degree atrioventricular block(Type two) ٢
degree atrioventricular block ٣
atrioventricular block
junctional escape beat
PR interval extension
Sinus Bradycardia

جدول ٣-٥: Ischemia and ST-T changes دسته

myocardial infarction
myocardial infraction in back wall
Myocardial infraction in the front wall
Myocardial infraction in the lower wall
Myocardial infraction in the side wall
ST drop down
ST extension
ST-T Change
ST tilt up
T wave Change
T wave opposite
U wave

جدول ٣-٦: Ventricular arrhythmia دسته

ventricular bigeminy
ventricular escape beat
ventricular fusion wave
ventricular premature beat
ventricular escape trigeminy

جدول ٣-٧: Supraventricular arrhythmia دسته

atrial bigeminy
atrial premature beats
junctional premature beat
Atrial Fibrillation
Sinus Tachycardia
Atrial Flutter
Sinus Irregularity
Supraventricular Tachycardia
Atrial Tachycardia
Atrioventricular Node Reentrant Tachycardia
Atrioventricular Reentrant Tachycardia
Sinus Atrium to Atrial Wandering Rhythm

جدول ٣-٨: Bundle branch abnormalities دسته

Interior differences conduction
Intraventricular block

left bundle branch block
left back bundle branch block
left front bundle branch block
left ventricle hypertrophy
right bundle branch block
right ventricle hypertrophy

جدول ۳-۹: دسته Abnormal parameters in ECG

Axis left shift
abnormal Q wave
Axis right shift
lower voltage QRS in all lead
lower voltage QRS in chest lead
lower voltage QRS in limb lead
QT interval extension
right atrial hypertrophy

جدول ۳-۱۰: دسته Pre-excitation

ventricular preexcitation
WPW

جدول ۳-۱۱: دسته Don't Care

counterclockwise rotation
clockwise rotation
Early repolarization of the ventricles
fQRS Wave
P wave Change
Wandering in the atrioventricular node

۳-۳-۴ آموزش

در آموزش مدل‌های یادگیری عمیق، استفاده از تابع زیانی^{۲۷} که آینه مناسبی از عمل کرد مدل باشد ضرورت دارد. برای آموزش مدل یادگیری پروژه گش از تابع زیان معرفی شده در مقاله مرجع استفاده شده است.

برای ارزیابی مدل‌های رگرسیون از ضریب تعیین برای سنجش برازش نتایج حاصله با مقادیر واقعی استفاده می‌شود:

$$R^2(x, y) = 1 - \frac{\sum_{i=1}^B (y_i - x_i)}{\sum_{i=1}^B (y_i - \bar{y})}$$

تابع زیان کلی به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\mathcal{L}_{total} = \mathcal{L}(Y, CLASS) + 0.2 \mathcal{L}_{FC}$$

که در آن از BCEWithLogitsLoss به عنوان $\mathcal{L}_{total}$ استفاده شده است؛ همچنین داریم:

$$\mathcal{L}_{FC} = \frac{R^2(\hat{x}_{upper}^c, \hat{x}_{lower}^c)}{R^2(x_{upper}^c, x_{lower}^c)}$$

در این تابع، از CLS token حاصل از خروجی transformer encoder ها استفاده شده است. در صورت کسر CLS token های اولیه و در مخرج کسر از CLS token های ثانویه استفاده شده است (شکل ۳-۱۲). علاوه بر تابع زبان که در بروز رسانی اوزان مدل کاربرد دارد، سنجش عملکرد مدل با استفاده از معیارهای recall_per_label، recall_macro، recall_micro، f1_per_label، f1_macro، f1_micro، acc_per_label، acc_macro و auroc_per_label به همراه سنجش مقدار پیشبینی های درست و نادرست لحاظ شده است.

به منظور سهولت آموزش، ابتدا داده ها تصفیه^{۲۸} شده و سپس نرخ نمونه برداری به ۱۰۰ نمونه بر ثانیه کاهش یافته است. بعد از حذف نمونه های نامناسب (فاقد برچسپ و ...)، ۷۰٪ داده ها برای آموزش، ۱۵٪ برای ارزیابی حین آموزش^{۲۹} و ۱۵٪ برای ارزیابی نهایی تفکیک و استانداردسازی نرمال روی آنها اعمال شده است. برای آموزش مدل، دسته های ۶۴ تایی^{۳۰} به همراه حداکثر ۲۰۰ بار عبور از دادگان آموزشی^{۳۱} لحاظ شده است. بهینه ساز^{۳۲} مورد استفاده AdamW بوده و نرخ یادگیری^{۳۳} اولیه یک هزارم تعیین شده است که با کمک CosineAnnealingLR به مرور کاهش می یابد. در صورتی که ارزیابی مدل بعد از ۱۰۰ مرحله بهبود نیابد، آموزش متوقف می شود.

آموزش مدل با استفاده از چارچوب^{۳۴} PyTorch روی پردازنده گرافیکی RTX 2080-Ti انجام شده است.

۳-۴- جمع بندی

در این فصل به تفصیل جزئیات پیاده سازی پروژه گش پرداختیم. ساختار کاربری سامانه در قالب وب اپلیکیشن و ساختمان مدل یادگیری بیان شد. به دادگان مورد استفاده در آموزش پرداختیم. همچنین توابع و پارامترهای استفاده شده در فرآیند آموزش را بیان کردیم.

Denoising^{۲۸}
validation^{۲۹}
Batch size = 64^{۳۰}
max(epochs) = 200^{۳۱}
optimizer^{۳۲}
Learning Rate^{۳۳}
Framework^{۳۴}

فصل چهارم نتایج

۴-۱- مقدمه

عملکردهای مدل‌های دسته‌بند به توانایی آن‌ها در دسته‌بندی موفق داده ورودی بستگی دارد. در این راستا دادگان مورد استفاده به سه بخش تقسیم می‌شود: بخش اول شامل داده‌های آموزشی است که در بروز رسانی اوزان مدل نقش دارد. در هر بار پیمایش مدل روی این داده‌ها اوزان مدل در جهت کاهش تابع زیان به روز می‌شود. بخش دوم داده‌ها شامل داده‌های ارزیابی است که نقشی در بروز رسانی اوزان ندارند و تنها در سنجش عملکرد حین آموزش نقش دارند. به ازای هر بار پیمایش داده‌های آموزشی و به روز رسانی اوزان، یک بار ارزیابی روی این داده‌ها انجام می‌شود. اینکار با اجتناب از بیش برآزش^{۳۵} قابلیت پایان زودهنگام آموزش را فراهم می‌کند. بخش سوم شامل داده‌های تست می‌شود که در ارزیابی نهایی مدل کاربرد دارد. در این فصل به بیان نتایج ارزیابی مدل یادگیری روی داده‌های تست می‌پردازیم.

۴-۲- ارزیابی مدل یادگیری

همانطور که در فصل ۳ بیان شد، برچسب‌های دادگان به هشت گروه تقسیم شدند. با اینحال، عدم تقارن شمار اعضای گروه‌ها مانعی برای دستیابی به نتایج مطلوب است. در این راستا دو مدل با معماری یکسان یکی با احتساب و دیگری بدون احتساب گروه‌های اقلیت آموزش دیدند. نتایج ارزیابی مدل‌ها در جدول‌های ۴-۱ تا ۴-۹ آمده است.

جدول ۴-۱: ارزیابی کلی مدل ۱ و مدل ۲

مدل ۲	مدل ۱	معیار ارزیابی
0.8990	0.7927	f1_micro
0.8732	0.3910	f1_macro
0.8871	0.7077	recall_micro
0.8564	0.3696	recall_macro
0.9361	0.9331	acc_micro
0.9361	0.9331	acc_macro

جدول ۴-۲: معیار ارزیابی F1-score به ازای هر برچسب.

این معیار دید متوازی از سنجش موارد موجود و صحت موارد تشخیص داده شده می‌دهد.

superclasses	Model 1	Model 2
--------------	---------	---------

Standard	0.8731	0.9181
Bradyarrhythmia	0.9422	0.9593
Ischemia and ST-T changes	0.3688	0.6604
Ventricular arrhythmia	0.0000	*
Supraventricular arrhythmia	0.9437	0.9550
Bundle branch abnormalities	0.0000	*
Abnormal parameters in ECG	0.0000	*
Pre-excitation	0.0000	*

جدول ۴-۳: معیار ارزیابی recall به ازای هر برچسب.

Recall به توانایی مدل در کشف تمام موارد مثبت موجود اشاره دارد.

superclasses	Model 1	Model 2
Standard	0.7970	0.8841
Bradyarrhythmia	0.9223	0.9423
Ischemia and ST-T changes	0.2855	0.6235
Ventricular arrhythmia	0.0000	*
Supraventricular arrhythmia	0.9522	0.9758
Bundle branch abnormalities	0.0000	*
Abnormal parameters in ECG	0.0000	*
Pre-excitation	0.0000	*

جدول ۴-۴: معیار AUROC به ازای هر برچسب.

معیار AUROC به ارزیابی مدل در کشف دو گروه (بیمار-سالم) می پردازد.

superclasses	Model 1	Model 2
Standard	0.9771	0.9879
Bradyarrhythmia	0.9804	0.9905
Ischemia and ST-T changes	0.7673	0.8834
Ventricular arrhythmia	0.8644	*
Supraventricular arrhythmia	0.9843	0.9923
Bundle branch abnormalities	0.7922	*
Abnormal parameters in ECG	0.7113	*
Pre-excitation	0.5596	*

جدول ۴-۵: معیار acc (accuracy) به ازای هر برچسب.

معیار Accuracy به سنجش درصد موارد صحیح تشخیص داده شده به کل موارد می پردازد.

superclasses	Model 1	Model 2
--------------	---------	---------

Standard	0.9577	0.9712
Bradyarrhythmia	0.9550	0.9682
Ischemia and ST-T changes	0.7679	0.8477
Ventricular arrhythmia	0.9890	*
Supraventricular arrhythmia	0.9472	0.9572
Bundle branch abnormalities	0.9494	*
Abnormal parameters in ECG	0.9005	*
Pre-excitation	0.9983	*

جدول ۴-۶: معیار TP به ازای هر برچسب.

معیار TP به شمارش موارد درست مثبت تشخیص داده شده می‌پردازد.

superclasses	Model 1	Model 2
Standard	970	1076
Bradyarrhythmia	2445	2498
Ischemia and ST-T changes	452	987
Ventricular arrhythmia	0	*
Supraventricular arrhythmia	2950	3023
Bundle branch abnormalities	0	*
Abnormal parameters in ECG	0	*
Pre-excitation	0	*

جدول ۴-۷: معیار FP به ازای هر برچسب.

معیار FP به شمارش موارد نادرست مثبت تشخیص داده شده می‌پردازد.

superclasses	Model 1	Model 2
Standard	35	51
Bradyarrhythmia	94	59
Ischemia and ST-T changes	416	419
Ventricular arrhythmia	0	*
Supraventricular arrhythmia	204	210
Bundle branch abnormalities	0	*
Abnormal parameters in ECG	0	*
Pre-excitation	۰	*

جدول ۴-۸: معیار TN به ازای هر برچسب.

معیار TN به شمارش موارد درست منفی تشخیص داده شده می‌پردازد.

superclasses	Model 1	Model 2
Standard	5412	5396
Bradyarrhythmia	3919	3954

Ischemia and ST-T changes	4665	4662
Ventricular arrhythmia	6591	*
Supraventricular arrhythmia	3362	3356
Bundle branch abnormalities	6327	*
Abnormal parameters in ECG	6001	*
Pre-excitation	6653	*

جدول ۴-۹: معیار FN به ازای هر برچسب.

معیار FN به شمارش موارد نادرست منفی تشخیص داده شده می‌پردازد.

superclasses	Model 1	Model 2
Standard	247	141
Bradyarrhythmia	206	153
Ischemia and ST-T changes	1131	596
Ventricular arrhythmia	73	*
Supraventricular arrhythmia	148	75
Bundle branch abnormalities	337	*
Abnormal parameters in ECG	663	*
Pre-excitation	11	*

عدم تقارن در شمار برچسب‌ها به ناتوانی مدل در استخراج ویژگی‌های نادر می‌انجامد. یکی از راه‌های غلبه بر این چالش، کاهش شمار نمونه‌های برچسب غالب برای توازن دادگان است؛ اما با توجه به تعداد بسیار پایین داده‌ها با برچسب‌های نادر، این کار بازدهی مناسبی ایجاد نخواهد کرد. حذف داده پرت^{۴۶} (در اینجا تنها برچسب پرت) می‌تواند عمل‌کرد بهتری داشته باشد. در این راستا مدل ۲ آموزش دیده و نتایج مطلوبی به بار آورد.

در قیاس نتایج این پروژه با مقاله مرجع باید به نکته زیر توجه داشت. در فاصله زمانی انتشار مقاله تا انجام پروژه حاضر، دادگان از ۱۰۰۰۰ نمونه به ۴۵۱۰۰ نمونه و از تک کلاسه به چند کلاسه به روز شده است. همچنین در مقاله از ۵ گروه برای دسته‌بندی استفاده شده است. لذا مقایسه پروژه حاضر با مقاله مرجع می‌بایست با احتیاط انجام شود.

۴-۳- جمع‌بندی

در این فصل به بیان نتایج آموزش مدل‌های یادگیری پرداختیم. دیدیم عدم تقارن دادگان سبب کاهش عمل‌کرد مدل می‌شود و با حذف برچسب‌های پرت در مدل ۲، به نتایج مناسب‌تری دست می‌یابیم.

فصل پنجم

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

پروژه گیش با هدف تسهیل درمان بیماری‌های قلبی توسعه یافت. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، مهمترین عامل مرگ و میر در سال ۲۰۲۱ بیماری‌های ایسکمی قلبی^{۳۷} بوده است.^۹ از آنجا که با افزایش سن، احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی بیشتر شده و شمار سالمندان جهانی رو به افزایش است، یافتن راهکارهای نوین برای پایش سلامت قلب ضروری می‌نماید. در این راستا، تحول‌های چند سال گذشته در زمینه هوش مصنوعی و سامانه‌های نهفته^{۳۸} (مثل فراگیری تلفن همراه هوشمند) می‌تواند راهگشا باشد.

امروزه هولترهای ECG و هولترهای فشار خون در مراکز درمانی سرتاسر جهان استفاده شده و نقش مهمی در تشخیص بیماری‌های قلبی ایفا می‌کنند. اما زمان کوتاه استفاده^{۳۹} و فناوری‌های سنتی به کار گرفته شده از مسائل قابل توسعه در این زمینه است.

با توجه به معرفی معماری‌های کارآمد یادگیری عمیق در دو دهه گذشته، توسعه مراکز داده^{۴۰}، صرفه اقتصادی سامانه‌های نهفته و اتصال بیشتر انسان‌ها به شبکه پر سرعت اینترنت، می‌توان به پیدایش و رواج نسل جدید هولترها امیدوار بود. هولترهایی که با وزن کمتر و استفاده طولانی‌تر قابلیت تشخیص خودکار ناهنجاری‌ها را داشته و انقباضی در مداوای بیماران قلبی به وجود آورند. علاوه بر این می‌توان امید داشت با رواج چنین دستگاه‌هایی به داده‌های بیشتری برای توسعه دادگان‌ها و حل چالش آموزش مدل‌های یادگیری فائق آمد^{۴۱}.

از معرفی اینترنت اشیاء در ۱۹۹۹ میلادی^{۱۰} تا امروز شاهد توسعه روزافزون این شاخه مهندسی بوده‌ایم؛ شاخه‌ای که خود به زیرشاخه‌های دیگری چون اینترنت خودروها^{۴۲}، اینترنت حیوانات^{۴۳}، اینترنت پهپادها^{۴۴} و اینترنت سلامتی^{۴۵} گسترش یافته است. همچنین همکاری این شاخه با هوش مصنوعی سبب ایجاد نگرش هوش اشیاء^{۴۶} شده است. امید است با تلاش دانشمندان جهانی شاهد توسعه اینترنت قلب^{۴۷} باشیم. شاخه‌ای برای پایش قلب و ارتقاء سلامت جهانی.

^{۳۷}جالب آنکه کووید ۱۹ دومین عامل مرگ و میر بوده است.

^{۳۸}Embedded System

^{۳۹}هولترهای ECG معمولاً برای دو روز (کمتر از یک هفته) تجویز می‌شوند.

^{۴۰}Data Center

^{۴۱}به شرط رعایت حریم خصوصی و حفظ امنیت بیماران

^{۴۲}Internet of Vehicles (IoV)

^{۴۳}Internet of Animals (IoA)

^{۴۴}Internet of Drones (IoD)

^{۴۵}Internet of Healthcare Things (IoHT) or Internet of Medical Things (IoMT)

^{۴۶}Artificial Intelligence of things (AIoT) - واژه مصنوعی برای سهولت خوانش حذف شده است.

^{۴۷}Internet of Hearts (IoH)

پیوست ۱: لیست برنامه‌ها

برای دسترسی به برنامه‌های نوشته شده پروژه گش به نشانی گیت‌هاب^{۴۸} پروژه مراجعه کنید.

۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی، درسنامه دستگاه قلب و عروق، تهران، ایران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، ۱۳۸۵.

- 2 S. A. Al-Mohammad, M. Ebrahimi, M. Ansari, A. Sari, E. Alavi, B. Fakhria, and M. Kerameddini, *Zist-shenasi (1): Payeh-ye Dahom-e Doreh-ye Dovom-e Motavasateh [Biology (1): Grade 10, Second Cycle of Secondary Education]*, 2nd ed. Tehran, Iran: Sazman-e Pazhoohesh va Barnamerizi-ye Amoozeshi, 1396.
- ۳ ف. جون، مهارت‌های حیاتی برای دانشجویان پزشکی: الکتروکاردیوگرام (ECG) ۲۰۲۰ (نوار قلب)، ترجمه س. غفاری، چاپ اول، تهران: ناشر نامشخص، ۱۴۰۰.
- 4 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK549803/figure/article-20969.image.f1/?report=objectonly>
- 5 S. Zhang, C. Lian, B. Xu, J. Zang, and Z. Zeng, "A token selection-based multi-scale dual-branch CNN-transformer network for 12-lead ECG signal classification," *Knowledge-Based Systems*, vol. 280, Art. no. 111006, 2023, doi: 10.1016/j.knosys.2023.111006.
- 6 A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, L. Kaiser, and I. Polosukhin, "Attention is all you need," in *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NeurIPS 2017)*, Long Beach, CA, USA, 2017, pp. 5998–6008.
- 7 A. Dosovitskiy, L. Beyer, A. Kolesnikov, D. Weissenborn, X. Zhai, T. Unterthiner, M. Dehghani, M. Minderer, G. Heigold, S. Gelly, J. Uszkoreit, N. Houlsby, "An image is worth 16×16 words: Transformers for image recognition at scale," in *Proc. Int. Conf. Learn. Representations (ICLR)*, 2021.
- 8 J. Zheng, J. Zhang, S. Danioko, H. Yao, H. Guo, and C. Rakovski, "A 12-lead electrocardiogram database for arrhythmia research covering more than 10,000 patients," *figshare*, 2019, doi: 10.6084/m9.figshare.11698521
- 9 World Health Organization, "The top 10 causes of death," Aug. 7, 2024. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death>. Accessed: Sep. 2, 2026.
- 10 B. B. Gupta and M. Quamara, "An overview of Internet of Things (IoT): Architectural aspects, challenges, and protocols," *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, vol. 32, no. 21, Art. no. e4946, 2020, doi: 10.1002/cpe.4946.